

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Decision Review

Reading Note 01 - applicazione esplicita dei gate a DEC-01

Artifact temporaneo di lettura

Questo documento non modifica R1, non costituisce R2 e non deve essere salvato nel repository. Serve a rendere visibili le domande dei gate prima di proseguire con le Decision successive.

Repository baseline	bb9eb66aeb611c3f1630e39f5511690b7eb6287f
Working record	R1 congelata e immutabile
Metodo	DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORIZING_GUIDE_R4
Parent element	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico
Elemento riesaminato	DEC-01 - Continuità' del triage in assenza di immagine
Base Analysis	BLOCCATA fino al documentation gate
Data	3 settembre 2026

Regola per questa fase

Per ogni Decision il working review record deve mostrare non solo l'esito del gate, ma anche la **domanda che il reviewer pone**, la risposta supportata dalla source evidence, l'eventuale gap, la disposition e la STOP decision.

1 Perché questa nota è necessaria

La R1 aveva già autorizzato una procedura esplicita per la prima Decision sotto MR-01:

1. source evidence;
2. candidate commitment;
3. Decision gate;
4. responsibility-boundary gate;
5. Decision-vs-current-realization test;
6. SELECTABLE / NECESSITY-CONSTRAINED / DEFAULT review;
7. semantic-sufficiency check;
8. explicit disposition e STOP decision.

Nella prima esposizione di DEC-01 i criteri sono stati applicati, ma sono stati compressi in una tabella di esiti. Questo rendeva meno auditabile il percorso *domanda -> evidence -> risposta -> disposition*.

Classificazione della discrepanza

Nessuna modifica metodologica proposta in questo momento. La regola era già presente nella guida e nella R1. La discrepanza viene classificata come **execution/presentation issue del working review**, non come method defect o metamodel pressure.

Resta aperta una osservazione metodologica: se il problema dovesse ripetersi, potrà essere utile rendere normativa nella guida la visibilità delle *gate questions*, non soltanto la registrazione dei gate applicati.

2 Source evidence minima per DEC-01

2.1 Evidence E1 - percorso principale con immagine

Source: OR2_Architecture_Document.pdf, sezione 2, pagina 1.

La fonte descrive un percorso principale nel quale il paziente fornisce un'immagine della lesione insieme a informazioni del caso; il sistema elabora l'immagine in una pipeline a più stadi e arriva a una decisione di triage.

2.2 Evidence E2 - fallback senza immagine

Source: OR2_Architecture_Document.pdf, sezione 2, pagina 2.

“Fallback: When no image is available, symptom-only scoring derives urgency from B4 chatbot interaction fields [...]”

Source proposition minima: se l'immagine non è disponibile, DermaTriage continua a derivare l'urgenza usando informazioni sintomatologiche del caso.

Cosa NON viene promosso da questa evidence

Il nome B4, i singoli campi sintomatologici e il dettaglio dello scoring non vengono automaticamente promossi a Decision. Devono essere classificati separatamente come boundary, FR semantics o realization evidence quando arriveremo al livello appropriato.

3 Candidate commitment e semantic owner

3.1 Candidate Decision

DEC-01 - Continuità del triage in assenza di immagine

Context. Il caso dermatologico può essere disponibile con un'immagine della lesione oppure senza immagine. La documentazione descrive un percorso principale image-based e un fallback symptom-only.

Decision. DermaTriage deve consentire la valutazione di triage anche quando non è disponibile un'immagine della lesione. In tale condizione, la determinazione dell'urgenza deve basarsi sulle informazioni sintomatologiche disponibili sul caso.

Consequences. La valutazione di triage deve supportare almeno le due condizioni "con immagine" e "senza immagine". La documentazione non autorizza a considerare automaticamente equivalenti gli output dei due percorsi oltre alla derivazione dell'urgenza.

3.2 Perché il semantic owner candidato è Decision

Il significato non è soltanto "eseguire uno scoring symptom-only": quello sarebbe già vicino a un obbligo funzionale. Il commitment più stabile è che **l'immagine non costituisce una precondizione assoluta per poter effettuare il triage**. Questa scelta restringe MR-01 senza descrivere ancora il comportamento operativo completo.

4 Decision gate - domande esplicite

4.1 Q-D2.1 - Esiste un material project commitment?

Gate / review

Domanda. La fonte governa una posizione progettuale materialmente significativa, oppure descrive soltanto un dettaglio esecutivo?

Risposta. SI. La possibilità di effettuare il triage in assenza di immagine modifica le condizioni di applicabilità della capability. Una soluzione alternativa avrebbe potuto richiedere l'immagine e rifiutare o rinviare il caso in sua assenza.

Esito: PASS.

4.2 Q-D2.2 - La Decision restringe esattamente un MR?

Gate / review

Domanda. DEC-01 restringe un solo MacroRequirement, oppure introduce responsabilita' autonome appartenenti ad altri branch?

Risposta. Restringe MR-01. Stabilisce come la responsabilita' di valutazione di triage si comporta rispetto alla disponibilita' dell'immagine; non introduce una macro-responsabilita' separata.

Esito: PASS.

4.3 Q-D2.3 - E' una tautologia dell'MR?

Gate / review

Domanda. Se rimuoviamo DEC-01, MR-01 implica gia' necessariamente che il triage debba funzionare senza immagine?

Risposta. NO. MR-01 governa la valutazione di triage dalle informazioni disponibili, ma non stabilisce da solo se l'assenza dell'immagine renda il caso non processabile.

Esito: PASS - non tautologica.

4.4 Q-D2.4 - Context, Decision e Consequences sono materiali?

Gate / review

Domanda. Il Context espone una tensione reale, la Decision dichiara una posizione e le Consequences producono effetti downstream materiali?

Risposta. SI. La tensione e' la disponibilita' o meno dell'immagine; la posizione e' continuare il triage; le conseguenze riguardano input ammessi, branch funzionali e output che potranno essere richiesti downstream.

Esito: PASS.

5 Split e non-ridondanza

5.1 Q-SPLIT.1 - Con immagine e senza immagine sono Decision indipendenti?

Gate / review

Domanda. Le due condizioni possono cambiare indipendentemente al punto da richiedere due commitment autonomi con trade-off separati?

Risposta. Non emerge evidence sufficiente per due Decision. Il significato governato qui e' uno: la continuita' del triage quando l'immagine manca. Il percorso image-based resta la condizione principale documentata e verra' ulteriormente analizzato attraverso altri commitment/FR.

Esito: PASS - NO SPLIT per DEC-01.

6 Responsibility-boundary gate

6.1 Q-RB.1 - DermaTriage possiede la capability o consuma un servizio esterno?

Gate / review

Domanda. La responsabilit  di produrre la valutazione di triage   del progetto DermaTriage oppure appartiene a B4/chatbot come servizio esterno?

Evidence. La sezione API distingue gli endpoint DermaTriage dalle “B4 External API Calls”. B4 fornisce consulti, documenti e campi di interazione e riceve risultati/validazioni; la pipeline di triage   descritta come responsabilit  DermaTriage.

Risposta. DermaTriage possiede la responsabilit  di triage; B4   una capability/integrazione consumata per ottenere o persistere informazioni del caso.

Esito: PASS.

Boundary preserved

Non trasformare “B4 chatbot” nel subject normativo di DEC-01. Il progetto puo’ cambiare il mezzo di acquisizione delle informazioni sintomatologiche senza cambiare il commitment fondamentale della Decision.

7 Decision-vs-current-realization test

7.1 Q-REAL.1 - Neutralizzando i nomi tecnici resta una scelta?

Gate / review

Domanda. Rimuovendo B4, chatbot e dettagli dello scoring, resta un commitment governato leggibile?

Risposta. SI: “il triage deve poter continuare anche senza immagine, usando le informazioni sintomatologiche disponibili”.

Esito: PASS.

7.2 Q-REAL.2 - Cambiare la realizzazione preservando MR-01 cambierebbe la strategia?

Gate / review

Domanda. Possiamo sostituire B4 o il meccanismo di scoring mantenendo invariata DEC-01?

Risposta. SI. Questo dimostra che B4 e lo scoring corrente non sono l’identit  della Decision. Al contrario, passare a una policy “no image -> no triage” cambierebbe il commitment pur lasciando invariato l’obiettivo macro di MR-01.

Esito: PASS - Decision separata dalla realization.

8 Decision kind review

8.1 Q-KIND.1 - SELECTABLE, NECESSITY-CONSTRAINED o DEFAULT?

Gate / review

Domanda. Esiste almeno un'alternativa materialmente distinta concepibile oppure la posizione e' una necessita' inevitabile del dominio?

Risposta. Esiste una alternativa materialmente distinta: richiedere obbligatoriamente l'immagine e non effettuare il triage quando manca. La fonte documenta la posizione scelta, ma non documenta il processo con cui l'alternativa e' stata valutata.

Kind candidate: SELECTABLE.

Proposition	Evidence status
Il sistema continua il triage senza immagine	AFFIRMED
Esiste una alternativa materialmente distinta concepibile	AFFIRMED per review strutturale; non equivale a storia decisionale documentata
Il team ha formalmente valutato quella alternativa	NOT SPECIFIED
Razionale storico della scelta	NOT SPECIFIED

9 Semantic-sufficiency check

9.1 Q-SEM.1 - Esistono letture materialmente diverse?

Gate / review

Domanda. Due reviewer potrebbero leggere "fallback symptom-only" in modi che producono downstream structure diversa?

Risposta. SI. Una lettura potrebbe assumere che il fallback produca l'intero outcome del percorso image-based; un'altra che produca soltanto l'urgenza.

9.2 Q-SEM.2 - Smallest critical proposition

Gate / review

Domanda. Qual e' la proposizione minima che separa le due letture?

Smallest critical proposition: "Il percorso symptom-only deve produrre l'intero insieme di output del percorso image-based, oppure soltanto l'urgenza?"

9.3 Q-SEM.3 - La fonte governa la proposizione?

La fonte afferma esplicitamente soltanto che il fallback symptom-only *derives urgency*. Non afferma equivalenza di pathology prediction, reasoning, clinical description, similar cases o altri output.

Evidence status: NOT SPECIFIED oltre all'urgenza.

9.4 Q-SEM.4 - Semantic owner corretto

Il gap non richiede di ampliare DEC-01. La Decision deve governare la continuità del triage; la forma e cardinalità degli output appartiene alla successiva review funzionale, se e quando la fonte la governa.

Semantic sufficiency disposition: PASS con gap preservato.

10 Disposition e STOP

DEC-01 disposition

DEC-01: PASS

Kind: SELECTABLE

Parent: MR-01

NS-01: rationale storico e alternative formalmente considerate - NOT SPECIFIED.

NS-02: equivalenza dell'output completo symptom-only rispetto al percorso image-based - NOT SPECIFIED; e' affermata soltanto la derivazione dell'urgenza.

10.1 STOP question

Gate / review

Domanda. Dopo DEC-01, esiste ancora significato governato che restringe materialmente MR-01 e che non può essere ridotto a FR/realization di DEC-01?

Risposta. SI. La documentazione distingue almeno un risultato analitico di urgenza HIGH/MEDIUM/LOW e una successiva assegnazione operativa P1-P4 con SLA. Questa relazione deve essere riesaminata come possibile commitment autonomo senza inglobarla in DEC-01.

STOP: NO - continuare la Decision review di MR-01.

11 Osservazione metodologica aperta

OBS-DDTA-DERMA-01 - Gate visibility

Osservazione: una tabella che riporta soltanto "Gate / PASS / motivazione" può essere troppo compressa per un artifact didattico o di ricerca, anche se il reviewer ha effettivamente applicato i test.

Ipotesi da verificare: il working review record potrebbe richiedere per ogni gate almeno *question + answer + evidence + disposition*, mentre la project documentation finale deve restare priva di questo commentary.

Stato: OPEN OBSERVATION - nessuna modifica alla metodologia R4 in questa fase.

12 Formato vincolante per la prossima Decision

Per DEC-02 la review verra' esposta nella stessa sequenza, senza saltare le domande:

1. Source evidence
2. Candidate commitment
3. Semantic owner
4. Decision gate questions + answers
5. Split / non-redundancy questions
6. Responsibility-boundary question
7. Decision-vs-realization questions
8. Decision kind question
9. Semantic-sufficiency questions
10. Explicit disposition
11. STOP question

Nessun FunctionalRequirement viene creato fino alla chiusura della Decision review pertinente.

13 Valutazione metodologica della sessione

Questa sezione chiude la nota di lettura con una valutazione della metodologia *limitata a quanto osservato fino a DEC-01*. Non e' ancora la valutazione conclusiva del holdout DermaTriage: pregi, difetti e proposte restano soggetti a conferma sulle Decision successive, sugli FR e sul documentation gate finale.

13.1 Pregi osservati

Pregio	Evidenza emersa in DEC-01	Stato
Separazione tra significato governato e realizzazione	Dal termine sorgente "fallback" e' stato estratto il commitment stabile "il triage puo' continuare senza immagine", senza trasformare automaticamente B4, chatbot o scoring in Decision.	CONFERMATO
Preservazione esplicita dell'incertezza	Il metodo ha impedito di assumere che il percorso symptom-only produca pathology, reasoning o tutti gli output del percorso image-based: tali aspetti restano NOT SPECIFIED.	CONFERMATO
Controllo del semantic owner	La continuita' del triage resta nella Decision; input sintomatologici, output e comportamento operativo vengono rinviati al livello funzionale appropriato invece di essere accumulati nella stessa entita'.	CONFERMATO
Responsibility-boundary discipline	La review distingue la responsabilita' di DermaTriage dalla capability esterna B4, evitando di attribuire al progetto ownership di servizi consumati.	CONFERMATO
Stopping discipline	Il PASS di DEC-01 non chiude artificialmente MR-01: la STOP question rende esplicito che esistono ancora commitment materiali da riesaminare.	CONFERMATO
Tracciabilita' del ragionamento	Quando le domande sono mostrate esplicitamente, il lettore puo' ricostruire perche' una proposizione e' diventata Decision, gap o realization evidence.	CONFERMATO, con condizione di visibilita'

13.2 Difetti, costi e rischi osservati

Costo / difetto	Manifestazione nella sessione	Stato
Elevato carico interpretativo sul reviewer	Distinguere Decision da FR e da realization non deriva meccanicamente dalla parola “fallback”; richiede neutralizzazione dei nomi tecnici, confronto di alternative e ownership review.	REALE
Rischio di compressione eccessiva dei gate	La prima esposizione di DEC-01 riportava gli esiti ma non rendeva visibili tutte le domande applicate; il metodo puo' risultare meno auditabile se il working record comprime troppo il processo.	REALE
Verbosity procedurale	Esplicitare domanda, evidence, risposta ed esito per ogni gate rende la review piu' lunga della documentazione progettuale ordinaria. Il costo e' accettabile nel working record, ma sarebbe eccessivo nel documento finale.	REALE
Possibile ambiguita' tra alternativa concepibile e alternativa storicamente valutata	La classificazione SELECTABLE richiede riconoscere che esiste una posizione materialmente diversa, senza inventare che il team l'abbia effettivamente considerata. Questa distinzione richiede attenzione.	REALE
Rischio di layer forcing	La gerarchia puo' spingere il reviewer a cercare una Decision anche quando la fonte contiene soltanto un obbligo funzionale. Il counterexample gate della R4 mitiga il rischio, ma dovra' essere verificato su altri casi.	DA VERIFICARE

13.3 Miglioramenti metodologici candidati

Miglioramenti da verificare, non ancora promossi

- Gate visibility contract.** Nel working review record rendere obbligatorio, per ogni gate materialmente applicabile, il formato minimo: question -> source evidence -> answer -> disposition. Il documento finale governato rimane invece sintetico.
- Evidence pointer esplicito.** Collegare ogni risposta critica al frammento o alla posizione della fonte che la sostiene, distinguendo evidence diretta da inferenza di review.
- Selectable-kind clarification.** Specificare nella guida che “esiste una alternativa materialmente distinta” non significa “la fonte documenta che il team l'ha valutata”. La seconda proposizione deve restare NOT SPECIFIED se manca evidence.
- Decision extraction worksheet.** Fornire una scheda didattica riusabile con le domande gia' in sequenza, cosi' il reviewer non puo' saltare accidentalmente responsibility boundary o Decision-vs-realization.

13.4 Valutazione complessiva dopo DEC-01

Valutazione provvisoria

Su DEC-01 la metodologia sta migliorando la documentazione DermaTriage in modo osservabile: trasforma una descrizione architetturale centrata sulla soluzione in un commitment progettuale piu' stabile, conserva i gap invece di completarli per inferenza e separa ownership, comportamento e realization.

Il principale costo osservato non e' una perdita di significato, ma **l'onere di review**: la qualita' dipende dalla capacita' di applicare i gate in modo disciplinato e di renderne visibile il ragionamento. La prima esecuzione compressa di DEC-01 mostra che questo rischio e' concreto anche quando le regole esistono gia' nella guida.

Conclusione della sessione: nessuna modifica a R4 e' giustificata ancora. OBS-DDTA-DERMA-01 resta aperta e viene verificata sulle prossime Decision. Se la necessita' di esplicitare le domande ricorre sistematicamente, il problema diventera' candidato a miglioramento della guida e non semplice errore di esecuzione.